

PIELONEFRITIS AGUDA

Iria Miguéns Blanco, Domingo Sánchez Sendín, Ana De Lorenzo Pinto, Raquel Sánchez García.

INTRODUCCIÓN

Se define pielonefritis aguda (PNA) por el cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre y bacteriuria, asumiendo además, invasión bacteriana del parénquima renal. Se trata de un cuadro cuyas complicaciones pueden ser graves, y se beneficiará de un diagnóstico y tratamiento precoz.

DIAGNÓSTICO

Se basará en los siguientes pilares:

Cuadro clínico: El 60% de los pacientes presentará fiebre, dolor lumbar y tiritona. Se asocia además, de malestar general, náuseas, vómitos, diarrea, mialgias. Los síntomas de infección de vías urinarias bajas pueden anteceder en 1 o 2 días a la propia pielonefritis.

Exploración física: con frecuencia puede haber puño percusión renal positiva del lado afecto. Ya en cuadros más graves, pacientes con shock séptico florido.

Pruebas complementarias: en el Servicio de Urgencias se debe realizar:

- Hemograma con formula leucocitaria (reactantes de fase aguda, recuento leucocitario)
- Bioquímica sanguínea con función renal, PCR.
- Sistemático y sedimento de orina (importante la presencia de cilindros leucocitarios que sugiere PNA).
- Urocultivo previo al tratamiento antibiótico.
- Ecografía abdominal. Se realizará en aquellos pacientes con importante afectación del estado general, signos de sepsis, factores de riesgo por uropatía obstructiva, sospecha de obstrucción. Fiebre persistente más allá de las 48-72 horas tras inicio de antibiótico.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS:

Medidas generales: importante hidratación, antitérmicos (paracetamol 650 mg cada 8 horas) y analgésicos (dexketoprofeno trometamol 25 mg cada 8 horas o metamizol magnésico 575 mg / 8 horas).

Si náuseas o vómitos, Metoclopramida 10 mg cada 8 horas u Ondansetrón 4 mg cada 8 horas.

Se tratarán de forma diferente las PNA no complicadas de las PNA complicadas. La primera dosis de la antibioterapia IV ha de ponerse en ambos casos en el Servicio de Urgencias.

PNA no complicada

- -Cefalosporinas de tercera generación vía oral, durante 10-14 días: Cefixima 400 mg cada 24 horas o cefditoreno en dosis de 200 mg cada 12 horas vía oral 10 - 14 días.
- - Alternativa: Amoxicilina Clavulánico 875/125 mg cada 8 horas por vía oral 14 días.

PNA complicada

- Sin riesgo de microorganismos multirresistentes (sospechar cuando: infección adquirida en el hospital, manipulación urológica reciente, sonda vesical permanente o tratamiento antibiótico previo). No criterios de sepsis grave.
 - Cefalosporinas de 3ª generación: Ceftriaxona 2 g cada 24 horas IV.

- Ertapenem en dosis de 1 g cada 24 horas.
- Aminoglucósido como tobramicina en dosis de 3-5 mg/ Kg / día
- Riesgo de infección por microorganismos multirresistentes o criterios de sepsis grave.
 - Monoterapia con un carbapenem IV:
 - Imipenem en dosis de 500 mg cada 6 horas
 - Meropenem en dosis de 500 mg cada 8 horas
 - Si alergia a beta lactámicos: Fosfomicina 4 g cada 8 horas asociando Vancomicina en dosis de 1 g cada 12 horas.

¡ PUNTO CLAVE!

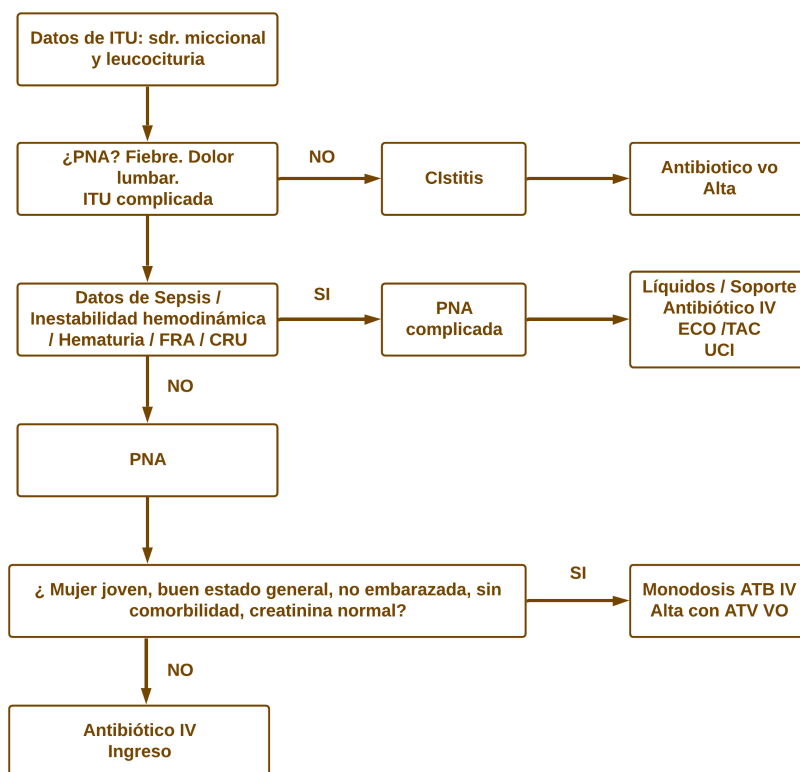
- El pronóstico y el riesgo de complicaciones mejorarán si se establece un diagnóstico e inicio de tratamiento precoz.
- Valorar evolución clínica de forma estricta si a las 48 horas persiste la fiebre o hay agravamiento del cuadro clínico, hay valorar microorganismos resistentes, colección supurada, o complicaciones del cuadro.

BIBLIOGRAFÍA

- Mensa J, Pigrau C, Horcajada JC, Carton JA, Pujol M. Infección Urinaria. Protocolos clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).
- Vázquez Lima, Manuel José. Casal Codesido, José Ramón. Guía de actuación en Urgencias. 4º edición. Esteve. Mayo 2013.
- Bent S, Nallamothu BK, Simel DK et al: Does this woman have an acute uncomplicated urinary tract infection ? JAMA 287: 2701, 2002.

ALGORITMOS

Manejo diagnóstico terapéutico de la Pielonefritis aguda



Mujer con síntomas de ITU aguda

